

„Chia seed internal shower“: čo na tom je a čo nie z pohľadu medicíny

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 10.10.2026



Ilustračná scéna. Vláknina s vodou má svoj zmysel – účinok je však bežný, nie zázračný.

Pacienti prichádzajú do ambulancie často s konkrétnou otázkou: „Pomohlo by mi pitie chia semienok na vyčistenie čriev?“ Trend „internal shower“ (ráno zjesť alebo zaliať chia semienka vodou, aby sa „vypláchol“ tráviaci systém) sa online šíri veľmi rýchlo. Medzi tým, čo chia skutočne ponúka nutrične, a tým, čo trend sľubuje, je však veľký rozdiel.

Čo je na chia semienkach reálne dobré

Chia semienka (*Salvia hispanica*) majú reálnu nutričnú hodnotu. V zdrojovom článku sa zdôrazňuje najmä:

- vysoký obsah vlákniny (2 polievkové lyžice približne 10 g vlákniny),
- omega-3 mastné kyseliny (alfa-linolénová),
- bielkoviny a minerály.

Keď sa chia zmieša s vodou, rozpustná vláknina vytvorí viskózný gél. Ten môže:

- pridať objem do stolice,
- zjemniť konzistenciu,
- podporiť prechod črevným traktom.

Toto nie je marketing. Je to bežná fyziológia vlákniny.

Kde sa medicína a marketing rozchádzajú

Sľub „internal shower“ vychádza z predstavy, že organizmus má „upchaté“ alebo „znečistené“ črevo a treba ho pravidelne „vypláchnuť zvnútra“. Pacientom treba povedať priamo: telo nie je upchatý odtok. Detoxikačné

procesy prebiehajú priebežne a bez pitia chia vody ich netreba „spúšťať“.

Zdrojový materiál to hovorí jasne:

- neexistuje recenzovaný (peer-reviewed) dôkaz, že voda s chia semenkami „čistí“ črevo viac, než by to dokázala bežná diétna vláknina.

Inými slovami: ak chia pacientovi pomôže, je to v prvom rade preto, že prijal vlákninu, nie preto, že by sa mu „vypláchol“ tráviaci systém.

Vláknina nie je pre všetkých rovnaká

Klinicky podstatný je typ vlákniny a to, ako ju črevo znáša, najmä pri:

- zápche,
- syndróme dráždivého čreva (IBS),
- nadúvaní a krčoch.

V zdrojovom článku sa uvádza, že:

- **psyllium** má najsilnejšiu dôkaznú bázu pre zlepšenie frekvencie a konzistencie stolice pri chronickej zápche,
- **nerozpustné vlákniny** (napr. pšeničné otruby) môžu u niektorých pacientov zhoršiť nadúvanie a diskomfort pri IBS,
- chia obsahuje rozpustnú aj nerozpustnú vlákninu, prevažuje však rozpustná zložka – mnohým pacientom to vyhovuje, ale nie každému.

Praktický dôsledok: odporúčanie „len pridajte vlákninu“ bez upresnenia typu a bez postupného zvyšovania dávky je zbytočné riziko. Najmä pri IBS môže ťažkosti zhoršiť.

Prečo môže chia trend pacientovi uškodiť

Podľa zdrojového materiálu je typický scenár takýto:

- pacient začne nárazovo (napr. „z nuly na plnú dávku“),
- do približne 72 hodín môže dôjsť k výraznému nadúvaniu, krčom a paradoxne aj k zhoršeniu zápchy.

Dôvod je jednoduchý: črevný mikrobiom potrebuje čas prispôbiť sa zvýšenému prísunu fermentovateľného substrátu a náhle zvýšenie môže zmeniť plynatosť aj motilitu.

Ako to komunikovať pacientovi v ambulancii (konkrétne odporúčanie)

Ak pacient chce chia napriek tomu vyskúšať, bezpečnejšie je dávku postupne titrovať:

- začať **0,5 až 1 polievkovou lyžicou denne**,
- dávku zvyšovať **postupne v priebehu niekoľkých týždňov**,
- a najmä **zabezpečiť dostatočný príjem tekutín**.

Pacientovi to treba povedať jasne: vláknina bez tekutín ťažkosti zhoršuje a môže zhoršiť pasáž.

Rozhovor možno zároveň presmerovať na postupy s oporou v dôkazoch:

- denný cieľ vlákniny sa v zdrojovom článku uvádza približne **25 až 35 g denne** z rôznych potravín,
- pri zápche má psyllium silnú oporu v štúdiách,
- ako doplnok v praxi môžu fungovať aj konkrétne potraviny (napr. slivky, kiwi, ovos),
- na motilitu má podstatný vplyv aj pohyb a denný režim.

Kedy nepokračovať v trende a riešiť príčinu

Zdrojový článok upozorňuje aj na druhú, klinicky veľmi dôležitú rovinu: ak pacient používa wellness trend na dlhšie trvajúce ťažkosti, môže oddialiť vyšetrenie.

Varovnými signálmi sú najmä:

- zápcha, ktorá pretrváva,
- snaha vyriešiť ťažkosti, ktoré trvajú mesiace, „receptom“ zo sociálnych sietí,
- príznaky, pri ktorých treba myslieť na liekovú príčinu, endokrinnú poruchu alebo funkčnú poruchu defekácie.

V takých prípadoch treba hľadať príčinu, nie iba zvyšovať vlákninu.

Osobitné poznámky pre nefrologických pacientov (CKD, dialýza)

Na toto trend často zabúda. Pri ochoreniach obličiek sa tekutinový režim môže líšiť podľa štádia a liečby. Preto:

- odporúčanie „zabezpečte dostatok tekutín“ treba pre nefrologických pacientov preložiť do reality ich **individuálneho tekutinového limitu**,
- pri dialýze je obzvlášť dôležité, aby pacient chvilu skúšal len v rámci odporúčaného režimu a po dohode s ošetrovateľským tímom,
- ak sa objaví zhoršenie nadúvania, kŕčov alebo pasáže stolice, trend treba zastaviť a prehodnotiť stratégiu zápch.

Nejde o to, že chia „je zakázaná“, ale o to, že v nefrologickej starostlivosti sa praktické detaily (najmä príjem tekutín) často musia upraviť, aby sa riziko minimalizovalo.

Zhrnutie

„Chia seed internal shower“ je typický príklad trendu, pri ktorom:

- **nutričná hodnota chia je skutočná** (najmä vláknina),
- **sľub „vyčistenia čriev“ nie je podporený klinickými dôkazmi**, ktoré by išli nad rámec účinku vlákniny,
- náhle zvýšenie dávky môže zhoršiť symptómy,
- najlepšie funguje individuálny prístup: postupná titrácia, dostatočná hydratácia podľa tolerancie a pri potrebe aj voľba vlákniny s lepšou dôkaznou oporou (napr. psyllium).

Zdroj: Medscape, článok „Chia Seed Cleanse: Where Medicine and Marketing Part Ways“ (2026). [Link na zdroj](#).

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=chia-seed-internal-shower-medicina-vs-marketing> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.